헬리코박터 제균 치료 안내

진단부터 약물 복용·재검사까지, 제균 성공의 핵심을 한눈에

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

치료 전에 — 한 장으로 보는 핵심

감염·진단·치료 대상은 개요 자료에서 자세히 설명하고, 이 자료는 치료를 시작하는 날의 설명입니다

왜 치료하나요

한국 성인 약 30%가 감염돼 있고, 감염되면 위암 위험이 약 6배입니다. 제균하면 위암이 약 35% 줄어듭니다.

어떻게 진단했나요

내시경 때 뗀 조직으로 검사하거나, 요소호기검사·대변 항원검사로 확인합니다.

꼭 치료하는 경우

위·십이지장 궤양, 위 말트 림프종, 조기 위암을 떼어 낸 뒤, 원인 모를 혈소판 감소는 꼭 제균합니다.

상의해 정하는 경우

위암 가족력, 위축성 위염·장상피화생, 원인 모를 철결핍 빈혈 등은 이득을 따져 함께 정합니다.

치료 뒤 확인 검사

요소호기검사나 대변 항원검사로 합니다. 혈액 항체검사는 과거 감염도 양성이라 쓰지 않습니다.

더 자세한 설명

감염 경로·검사 종류·누가 치료받나는 헬리코박터 개요 자료에 있습니다.

Tip · 해당하는지 헷갈리면 진료 때 결과지를 함께 보며 정합니다.

근거 · 대한헬리코박터·상부위장관연구학회 진료지침 2022 · 국제암연구소(IARC) · 건강보험 적용 기준

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

위산 속에서 살아남는 나선형 세균입니다

한 번 감염되면 저절로 없어지지 않고, 오랜 염증이 단계적으로 위 점막을 바꿉니다

1

만성 위염

감염 뒤 평생

균이 스스로를 보호하는 효소(요소분해효소)로 위산을 견디며 위 점막에 자리잡고 염증을 일으킵니다.

2

위축성 위염

수십 년

염증이 오래가면 위 점막이 얇아집니다.

3

장상피화생

전암성 변화

위 점막이 장 점막처럼 바뀝니다. 위암 위험이 높아지는 단계입니다.

4

위암

일부에서

모든 감염자가 위암이 되지는 않지만, 헬리코박터가 이 흐름의 출발점입니다.

언제·어떻게 옮나요 대부분 어린 시절 가족 안에서 옮습니다 — 감염 경로·검사 방법은 개요 슬라이드 edu.gwanggyobarun.com/decks/gi/hpylori-overview/

Tip · 이 흐름을 일찍 끊는 것이 제균 치료의 목적입니다.

근거 · 대한헬리코박터·상부위장관연구학회 진료지침 2022 · 코레아 위암 발생 단계

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

처음 치료할 때 쓰는 약 조합

국내 지침은 내성검사에 맞춘 치료를 우선하며, 경험적 치료로 10일 동시요법 등을 권합니다

조합	들어가는 약 · 먹는 횟수	기간
표준 삼제요법 내성 확인 후	위산억제제(PPI) 표준용량 · 아목시실린 1000mg · 클라리스로마이신 500mg — 모두 **하루 2번(아침·저녁)**	14일
비스무트 사제요법	위산억제제 표준용량 · 비스무트 600mg · 테트라사이클린 1000mg · 메트로니다졸 750mg — 모두 **하루 2번(아침·저녁)**	처방에 따라 10일 또는 14일
동시요법 비스무트 없음	위산억제제 표준용량 · 아목시실린 1000mg · 클라리스로마이신 500mg · 메트로니다졸 500mg — 모두 **하루 2번(아침·저녁)**	10일

왜 조합이 다를까요 최근 국내 조사(2021~2023년)에서 클라리스로마이신 내성률은 약 33%였습니다. 내성검사 결과에 따라 약을 고릅니다.

Tip · 어떤 조합이든 처방받은 횟수와 기간을 그대로 지키는 것이 가장 중요합니다.

근거 · 대한상부위장관·헬리코박터학회 진료지침 2025

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

1차 치료가 실패해도 다음 단계가 있습니다

1차 성공률은 약 70~85% — 단계를 거치면 대부분 제균됩니다

2차 · 비스무트 사제요법

1차에서 쓰지 않았다면 먼저 씁니다. 위산억제제·비스무트·테트라사이클린·메트로니다졸 모두 하루 2번(아침·저녁).

2차 · 레보플록사신 삼제요법

위산억제제·아목시실린 1000mg 하루 2번, 레보플록사신 500mg 하루 1번을 14일 먹습니다.

3차 · 맞춤 치료

균 배양으로 잘 듣는 항생제를 확인해 고르거나, 리파부틴이 든 조합을 검토합니다.



설명용 그림 · 치료 단계를 거칠수록 균이 줄고, 마지막에 요소호기검사·대변 검사로 제균을 확인합니다.

Tip · 2차 치료 성공률은 약 70~80%, 단계를 모두 거친 누적 성공률은 95% 이상입니다.

근거 · 대한헬리코박터·상부위장관연구학회 진료지침 2022

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

치료 시작부터 제균 확인까지

약을 끝낸 뒤 충분히 기다려야 재검사가 정확합니다



설명용 그림 · 알약과 달력 — 정해진 기간 동안 빠짐없이 먹어야 균이 없어집니다.

1 치료 시작 첫날

처방받은 약을 정해진 시간에 먹기 시작합니다. 첫날부터 술을 마시지 않습니다.

2 치료 끝 처방 기간

한 알도 빼먹지 않고 끝까지 먹습니다. 가벼운 부작용은 스스로 끊지 말고 연락합니다.

3 기다리기 4주 이상

재검사 전 위산억제제는 최소 2주, 항생제는 4주 이상 끊어야 합니다. 그 사이 다른 항생제를 먹었다면 검사 날짜를 다시 정합니다.

4 제균 확인 재검사

요소호기검사나 대변 항원검사로 확인하고, 양성이면 2차 치료를 검토합니다.
요소호기검사 4시간 전부터 금식해 주세요(물도 드시지 마세요).

Tip · 재검사 전 위산억제제를 언제 끊을지는 의사 지시에 따릅니다.

근거 · 대한헬리코박터·상부위장관연구학회 진료지침 2022

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

제균의 성패는 약을 빠짐없이 먹는 데 달렸습니다

처방 그대로, 끝까지 드세요

정해진 시간에

처방 시간표대로 — 흔히 위산억제제는 식사 30분 전, 항생제는 식사 직후에 먹습니다.

메트로니다졸 복용 시 금주

복용 중과 마지막 복용 뒤 72시간 동안 술을 마시지 마세요. 메스꺼움·구토·얼굴 붉어짐이 생길 수 있습니다.

빼먹지 말고 끝까지

덜 먹으면 약이 안 듣는 균이 생깁니다. 좋아져도 끝까지, 빼먹었으면 바로 문의하세요.

약을 멈추고 연락 · 숨이 차면 응급실

심한 설사·발진·황달이면 약을 멈추고 연락하세요. 지사제는 스스로 먹지 마세요.



설명용 그림 · 치료 중에는 술을 멀리하고, 발진 같은 이상이 생기면 바로 알립니다.

Tip · 메트로니다졸 복용 중과 마지막 복용 뒤 72시간 동안 금주하세요.

근거 · 미국 국립의학도서관 메트로니다졸 복약정보(MedlinePlus)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

흔한 부작용은 대부분 가볍습니다

미리 알아 두면 당황하지 않습니다 — 약을 끝내면 대개 사라집니다

대개 가벼움 — 계속 드세요

치료를 마치면 좋아집니다

- 메스꺼움·입맛 없음 — 식사와 함께 먹으면 덜합니다
- 설사·배 불편감 — 항생제 때문이며 보통 가볍습니다
- 쓴맛·쇠 맛(약을 끊으면 회복), 두통·어지러움(며칠 안에 좋아짐)
- 검은 변 — 비스무트 때문에 흔함(출혈 변과는 구분 필요)

VS

약을 멈추고 바로 병원에 연락

약을 바꾸거나 멈춰야 할 수 있습니다

- 물설사가 하루 6번 이상
- 몸 전체에 퍼지는 발진·가려움(약 알레르기 가능)
- 눈이나 피부가 노래짐(황달)
- 두통·어지러움이 심해 일상이 어려움

이럴 땐 응급실로 짜장처럼 검고 끈적한 변이나 그와 함께 어지럼이 있을 때(출혈 가능성), 약을 먹은 뒤 숨이 차거나 얼굴·입술이 부을 때.

Tip · 경미한 부작용은 약 20~30%에서 생기고, 이 때문에 치료를 멈추는 경우는 5% 미만입니다.

근거 · 대한헬리코박터·상부위장관연구학회 진료지침 2022

전에 약을 먹고 생긴 반응을 알려 주세요

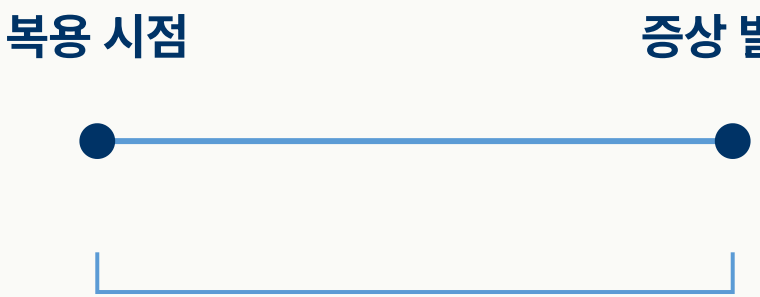
김태범 교수 강의 · 약 이름과 반응의 모양을 함께 확인합니다.

최근 1개월의 약

바로 며칠 전 약뿐 아니라 최근 1개월 동안 먹은 약까지 확인합니다. 과거 약물 과민반응도 알려 주세요.

복용과 증상의 관계

약을 먹은 뒤 언제, 어떤 증상이 시작되었는지 살핍니다. 두드러기·부종·발열·붉은 발진 등을 구분합니다.



복용한 약과 증상이 시작된 날짜를 함께 확인합니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

약물반응은 늦게 시작될 수도 있습니다

발생 시점을 기억하면 원인 약을 찾는 데 도움이 됩니다.

1

1시간 이내

즉시형 반응으로 두드러기·혈관부종·아나필락시스가 나타날 수 있습니다.

2

1~72시간

중간 시기에 두드러기나 부종, 피부 발진·열이 생길 수 있습니다.

3

72시간 이후

지연형 발진이나 심한 피부 약물반응이 나타날 수 있습니다.

4

2주~2개월

DRESS는 늦게 생긴 발진과 함께 열·림프절 비대·장기 이상이 동반될 수 있습니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

두드러기와 부종은 어떻게 보이나요?

즉시형 약물 과민반응의 피부 모양입니다.

두드러기

모기에 물린 듯 부풀어 오르고 가려운 병변이 나타날 수 있습니다.

옮겨 다니는 모양

일반적인 두드러기는 한 곳에 24시간 이상 머무르지 않고 다른 곳으로 옮겨 다니는 양상을 보입니다.

혈관부종

입술이나 눈꺼풀처럼 더 깊은 조직이 붓기도 합니다. 기도를 침범하면 숨쉬기 어려울 수 있습니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

호흡곤란이나 쓰러질 듯한 증상은 응급입니다

두드러기·부종과 전신 증상을 함께 봅니다.

피부와 점막

전신 두드러기나 입술·눈꺼풀 부종이 생길 수 있습니다.

호흡기

숨이 차거나 쌕쌕거리고 목 안쪽이 붓는 증상이 동반될 수 있습니다.

혈압·의식

어지럽고 쓰러지거나 혈압이 떨어질 수 있습니다.

즉시 대응

이런 증상이 함께 나타나면 아나필락시스 같은 전신 과민반응을 생각하고 바로 응급 처치를 받습니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

붉은 발진과 수포·점막 증상을 구분합니다

발열과 다른 장기 증상도 함께 확인합니다.

반구진성 발진

붉은 반점과 약간 솟은 발진

- 흔한 지연형 피부반응으로 소개되었습니다.
- 가려움이나 발열이 동반될 수 있습니다.
- 의심 약을 확인하고 중단·치료 여부를 판단합니다.

vs

중증 피부반응

수포·피부 박리·점막 침범

- 입안·눈·생식기 점막에 증상이 나타날 수 있습니다.
- 고열·전신 불편감이나 간·콩팥 이상이 함께 생길 수 있습니다.
- 원인 약을 신속히 중단하고 상급병원 진료가 필요합니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

눈·입안 증상이 있으면 조기에 평가합니다

스티븐스존슨증후군의 특징으로 소개한 내용입니다.

눈 침범 > 60%

눈 침범

강의에서는 스티븐스존슨증후군의 60% 초과에서 눈 침범이 생길 수 있다고 설명했습니다.

함께 보는 증상

수포와 피부가 벗겨지는 변화, 입안·생식기 점막 증상, 발열이 나타나는지 살핍니다.

치료를 서두르는 이유

원인 약을 빨리 중단하고 상급병원으로 의뢰하며, 눈 합병증 예방을 위해 조기 안과 진료가 중요하다고 강조했습니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

알레르기 검사는 병력에 맞춰 선택합니다

사전 선별검사와 반응 후 원인 확인검사를 구분합니다.

검사·평가	강의에서 설명한 용도
약물 병력	어떤 약을 먹고 언제 어떤 반응이 있었는지 확인하는 것이 첫 단계입니다.
피부검사	즉시형 과민반응이 있었던 사람에서 원인 약을 확인할 때 사용합니다.
혈액검사	일부 페니실린계·세파클러 등의 특이 IgE 검사로 보조할 수 있습니다.
경구 유발시험	다른 검사로 확인하기 어렵거나 대체 약을 찾을 때, 응급 처치 준비와 의료진 관찰 아래 시행합니다.

알레르기 병력이 없는 사람에게 항생제 사전 피부시험을 일률적으로 시행할 필요는 없다고 설명했습니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

대체 항생제는 구조와 과거 반응을 살핍니다

김태범 교수 Q&A · 계열 이름이나 세대만으로 판단하지 않습니다.

곁사슬의 유사성

페니실린과 세파계 항생제의 교차반응은 R1 곁사슬이 같거나 비슷한지가 중요합니다.

과거 반응의 중증도

가벼운 두드러기였는지, 아나필락시스였는지, 심한 지연성 발진이었는지 구분해 평가합니다.

개별적으로 대안을 정합니다

연자는 반응과 구조가 다른 약을 전문의 감독하에 평가하는 접근을 설명했습니다. 약물반응 기록을 보여 주세요.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

치료 기간 동안 지킬 일곱 가지

단순하지만 제균 성공을 가르는 규칙입니다

01 처방받은 약을 정해진 시간에 정확히 먹기

02 메트로니다졸 복용 중·마지막 복용 뒤 72시간 금주

03 증상이 좋아져도 마음대로 끊지 않기

04 한 번 빼먹었다면 바로 병원에 문의

05 치료가 끝나고 4주 이상 지나 재검사 예약

06 재검사 전 위산억제제 2주 끊기(의사 지시대로)

07 가족도 검사·치료를 함께 상의하기

Tip · 한 번에 끝내는 것이 가장 쉽고 효율적입니다.

근거 · 대한헬리코박터·상부위장관연구학회 진료지침 2022

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

다시 보기 · 문의

QR로 다시 보기 · 집에 가져갈 한 장은 제균 치료 안내문(복약 점검표)입니다

광교바른내과

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 드림타워2 4층 402~404호 · **031-893-4560**
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

이 자료의 성격

헬리코박터 제균 치료를 시작하는 분과 가족을 위한 설명자료입니다. 약 조합과 기간은 담당 의사가 정합니다.

참고한 자료

대한상부위장관·헬리코박터학회 진료지침 2025 · 국제암연구소(IARC) 발암물질 분류 · 건강보험 적용 기준

SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서 같은 자료를 다시 볼 수 있어요

함께 보기 — 제균 치료 복약 점검표 edu.gwanggyobarun.com/handouts/gi/h-pylori-eradication/